CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adherencia a Guía de Práctica Clínica – Hipertensión Arterial Aguda

Parámetro 1. Identificación y clasificación inicial de presión arterial elevada

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó una evaluación inicial orientada a clasificar adecuadamente al paciente con elevación de presión arterial, diferenciando emergencia hipertensiva de presión arterial elevada asintomática?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica:
Debe evidenciarse:

- Registro de cifras tensionales.
- Confirmación de medición (repetición si aplica).
- Evaluación de signos y síntomas sugestivos de daño agudo a órgano blanco.
- Clasificación clínica del paciente según hallazgos.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Se registra medición, confirmación, evaluación clínica y clasificación final.

4 – Cumple adecuadamente:
Se registra presión arterial, realiza clasificación, no registra evaluación signos/síntomas

1 – No cumple:
No se evidencia clasificación ni evaluación estructurada.

Parámetro 2. Evaluación y documentación de daño a órgano diana

Pregunta de evaluación: ¿Se realizó búsqueda y documentación de compromiso agudo a órgano blanco en pacientes con elevación severa de presión arterial?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica:
Debe incluir evaluación clínica dirigida a:

- **Cerebro:** cefalea, déficit neurológico, alteración del estado mental.
- **Corazón:** dolor torácico, disnea, signos de falla cardíaca.
- **Riñón:** oliguria, hematuria, alteración función renal.
- **Sistema arterial periférico:** pulsos disminuidos, extremidades frías.
- **Retina cuando aplique.**

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Realiza valoración completa y deja conclusión sobre presencia o ausencia de daño.

4 – Cumple adecuadamente:
Describe síntomas pero no concluye compromiso de órgano diana.

1 – No cumple:
No evalúa daño agudo a órgano blanco.

Parámetro 3. Solicitud e interpretación de exámenes complementarios

Pregunta de evaluación: ¿Se solicitaron y analizaron oportunamente exámenes complementarios en pacientes con sospecha de emergencia hipertensiva?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe documentarse solicitud o revisión de:

- Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Radiografía de tórax.
- Función renal (creatinina, BUN).
- Hemograma.
- Otros estudios según contexto clínico.
- Interpretación y conducta derivada.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Solicita exámenes pertinentes, interpreta y define conducta.

4 – Cumple adecuadamente:
Solicita exámenes pero sin interpretación clínica.

1 – No cumple:
No solicita ni interpreta estudios requeridos.

Parámetro 4. Evaluación de factores asociados a elevación de la presión arterial

Pregunta de evaluación:
¿Se evaluaron causas potencialmente reversibles asociadas a elevación de presión arterial asintomática antes de modificar tratamiento antihipertensivo?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe evidenciar valoración de:

- Dolor.
- Ansiedad o estrés.
- Sobrecarga de volumen.
- Suspensión de antihipertensivos domiciliarios.
- Medicamentos que elevan PA.
- Técnica de medición.
- Factores hospitalarios asociados.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Documenta evaluación integral de factores precipitantes y corrige causas identificadas.

4 – Cumple adecuadamente:
Registra algunos factores sin establecer conducta.

1 – No cumple:
No evidencia evaluación de factores contribuyentes.

Parámetro 5. Pertinencia del tratamiento antihipertensivo instaurado

Pregunta de evaluación: ¿El tratamiento instaurado fue acorde con la clasificación clínica del paciente y el contexto asistencial?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe evidenciar:

- Correspondencia entre manejo y clasificación.
- Uso de antihipertensivos IV en emergencia hipertensiva cuando aplique.
- Individualización del manejo en pacientes asintomáticos.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Tratamiento coherente con clasificación y justificación clínica.

4 – Cumple adecuadamente:
Tratamiento adecuado pero sin justificar.

1 – No cumple:
Manejo no acorde o intensificación injustificada.

Parámetro 6. Cumplimiento de metas de reducción de presión arterial (Emergencia hipertensiva)

Pregunta de evaluación: ¿Se establecieron y documentaron metas terapéuticas de reducción de presión arterial acordes con el órgano comprometido?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir:

- Objetivo de reducción.
- Ajustes según evolución clínica.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Documenta metas específicas y seguimiento.

4 – Cumple adecuadamente: Menciona reducción esperada sin metas claras.

1 – No cumple: No establece metas terapéuticas.

Parámetro 7. Conducta al egreso y continuidad del manejo

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó un plan de egreso y seguimiento acorde con el estado clínico del paciente?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir:

- Educación al paciente.
- Plan de seguimiento ambulatorio.
- Indicaciones de monitoreo posterior.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Registra conducta completa de egreso y seguimiento.

4 – Cumple adecuadamente: Menciona control posterior sin plan estructurado.

1 – No cumple: No evidencia plan de seguimiento.

La metodología de evaluación propuesta fue revisada y validada por el Grupo Estratégico y Clínico de GPC. Durante dicha revisión se consideró que la herramienta presenta preguntas claras y pertinentes para evaluar la GPC de Hiperplasia Prostática Benigna conforme a las recomendaciones trazadoras.